ST. LUKE'S ICU ／ GUIDELINE DIGEST

生命維持治療の終了と差し控え — 4学会合同ガイドライン2026

終末期を定義せず、多職種の検討と共同意思決定で決める。なぜ改訂したか・誰がどう決めるか・3つの選択肢・終了の実際・症状緩和の薬・家族と医療者のケア・BSCの代わりに書くこと・家族等とは誰か・記録と法的な位置づけを扱う

聖路加国際病院 集中治療科　対象：医師・看護師・多職種　最終更新 2026-10-07

人工呼吸器や昇圧薬を続けることが、本人の望む生き方と合わなくなる場面がICUにはあります。2026年9月、日本集中治療医学会・日本救急医学会・日本循環器学会に日本緩和医療学会が加わり、2014年の「救急・集中治療における終末期医療に関するガイドライン」を全面改訂しました。この資料は、本編・説明文・Q&A集・緩和ケア別編の4分冊を、現場で使う順に並べ直した解説です。持ち帰るのは、①「終末期かどうか」ではなく多職種の検討と共同意思決定（SDM）という手順で決める、②差し控えと終了は倫理的に同じなので「やめられないから始めない」をしない、③緩和ケアの準備なしに終了しない、の3点です。

✓ 要点：このガイドラインを1行で

終末期を定義せず、多職種の臨床倫理的検討（4観点）と厚労省プロセスガイドラインに沿ったSDMで、差し控え・終了・期限付きの試行（TLT）のどれが患者の価値観に沿うかを決め、どれを選んでも緩和ケアを最大限続け、経緯をすべて記録します [本編]。

§1 なぜ改訂したか：「やめられないから始めない」をなくすため

2014年版は人工呼吸器を含む生命維持装置を終了できると明言していましたが、現場では終了がほとんど行われませんでした。この章では、旧版のどこがつまずきになったのかと、そのために変えた言葉を確かめます。

この章のポイント

1. 終末期の定義をやめ、手順で決める形に変えた
2. 法的な不安と、終了後の緩和ケアの空白を埋めた
3. 「中止」を「終了」と言い換え、BSCの代わりに中身を書く

1-1. 旧版は「終末期」の4例示が狭く読まれ、死の直前まで終了できなかった

旧版の4つの例示は「この4つだけが終末期」と解釈され、旧Q&Aが「近いうち＝おおよそ2〜3日以内」と答えたため、望まない生命維持治療が死の直前まで続く運用が残りました（表1） [説明文]。

救命だけをゴールにすると、生命維持治療で生命が保てる限り、「救命の見込みがない時期」にはなりません。治療が進歩するほど、終末期という入口そのものが遠のきます。旧Q&Aは「予後の予測が困難なら本ガイドラインを使用すべきではない」ともしていましたが、ICUでは予後予測は本来困難です [説明文]。

表1｜旧版のつまずきと新版の答え：終末期を決める代わりに、手順を決めた

旧版（2014）の記載	現場で何が起きたか	新版（2026）の対応
終末期＝「適切な治療を尽くしても救命の見込みがないと判断される時期」	生命維持治療で生命が保てる限り終末期にならず、望まない治療が続く	終末期をあえて定義しない
終末期の4例示（不可逆的な全脳機能不全／移植等の代替手段もない複数臓器の不可逆的機能不全／近いうちに死亡が予測される／回復不可能な疾病の末期が治療開始後に判明）	「相当する場合など」と幅を持たせたのに、4パターンだけが終末期と読まれた。「近いうち」は2〜3日以内とされた	病態は4観点の検討のうち「医学的側面」として個別に評価する（Q8）
「緩和的な措置は継続する」「筋弛緩薬投与などの手段により死期を早めることは行わない」	終了後に何をすればよいか分からず、緩和と安楽死の区別も示されなかった	緩和ケア別編を新設。安楽死は現在の日本では違法となるため、本ガイドラインでは扱わない

1-2. 2つの空白が「やめられないから始めない」を生んでいた

旧版の課題は、①終了に伴う法的リスクの懸念を払拭できなかったこと、②決めた後の緩和ケアの具体的な指針がなかったことの2つでした。これらが、救命できるかもしれない患者の初期治療をためらわせる危険を生んでいました [本編] [説明文]。

一度始めた生命維持治療は、本人の意思に沿っていても終了がきわめて難しいと感じている現場では、「やめられないなら最初から始めない」という判断が起きます。新版は、法的な位置づけの整理（§7）と緩和ケア別編（§4・§5）で2つの空白を埋めました [説明文]。

表2｜2014年版から何が変わったか：提言から、臨床倫理のガイドラインへ

項目	2014年版	2026年版
学会	集中治療・救急・循環器の3学会	日本緩和医療学会が加わり4学会
性格	提言	意思決定と意思決定支援の臨床倫理ガイドライン（厚労省プロセスガイドラインと同種）
作り方	記載なし	修正デルファイ法＋パブリックコメント（§8）
終末期	定義し、4つの例示	あえて定義しない
判断の枠組み	医療チームが終末期と判断	多職種の臨床倫理的検討（4観点）＋SDM＋コミュニケーションスキルトレーニングの推奨
TLT	記載なし	明記（一度始めた治療もやめられることを強調）
緩和ケア	「緩和的措置」の一言	本編に総論、緩和ケア別編に各論（薬剤・用量・家族ケア・医療者ケア）

対象は、疾患や診断名にかかわらず、救急搬送された患者・ICUへ緊急入室した患者等、急性期病院で治療の意思決定を行うすべての患者です。従来の定義の「終末期」には限定されません（Q14） [本編]。

1-3. 言葉を変えた：「終了」と言い、「延命治療」「BSC」は使わない

「中止」は再開を含みうるので「終了」に統一し、「延命治療・延命措置」「消極的安楽死」「BSC」は使わないと決めました（表3） [説明文]。

症状緩和の治療は続くので、終わるのは「治療」ではなく「生命維持治療」です。生命維持治療には人工呼吸器や補助循環だけでなく、昇圧薬・ペースメーカー・人工栄養・水分補給・透析などの血液浄化・輸血・輸液も、状況によって含まれます [本編 注釈1]。

表3｜用語の整理：言い換えるのは、誤解を生む言葉だけ

用語	扱い	理由
終末期	あえて定義しない	学会や場面で意味が違う。存在は否定しないが、一律の基準では定義できない（Q8）
延命治療・延命措置	使わない	根治を目指す治療のどこからが単なる延命かを区切れない
生命維持治療の中止	「終了」に統一	「中止」は再開もありうると理解される。意向の変更を否定する趣旨ではない（Q7）
消極的安楽死	使わない	終了・差し控えは病の自然な経過を受け入れる判断で、生命の短縮を目的としない。安楽死との区別が曖昧になる
BSC（best supportive care）	使わない	中身が示されず、「もう治療はしない」「見放した」と受け取られやすい。代わりに書くことは1-4
治療・ケアのゴール	定義した	患者の目指す生き方・価値観・優先順位に基づく方針の指針。例「退院して社会復帰する」「残された時間をできるだけ苦痛なく過ごす」（注釈3）
家族等	法的親族に限らない	本人の価値観をよく知る人（2-4）

1-4. 「BSC」とは書かない：何を続け、何を控え、何を終えるかを書く

終了・差し控えが決まった後の治療やケアを「BSC（best supportive care）」と表現すると中身が具体的に示されず、本人・家族等に「もう治療はしない」「見放した」と受け取られやすいため、4学会GLはこの言葉を使わず、決めた後の緩和ケアを緩和ケア別編で具体的に示しました [説明文]。

「BSC」「緩和の方針」の一言では、どの治療を続け、どれを始めず、どれをやめるのかが、チームにも家族にも伝わりません。DNARと同じく、ひとことの方針が「全部控える」に読み替えられる危険もあります（3-4） [Q37]。代わりに、ゴールと、治療ごとの扱いと、苦痛を取る中身を書きます（表4）。

表4｜「BSC」の代わりに書くこと：ゴール・治療ごとの扱い・苦痛緩和の中身

書く項目	中身	ガイドラインの拠り所
治療・ケアのゴール	本人の価値観に基づくゴールを言葉で書く。例「残された時間をできるだけ苦痛なく過ごす」	本編 注釈3
続ける治療・ケア	鎮痛・鎮静薬など症状緩和の治療（症状緩和に使っている強心薬は必ずしも減らさない）、口腔ケア・保清などのケア	本編 I-2-1、Q40、Q44
差し控える治療（始めない・増やさない）	新たな治療の開始と増強。人工呼吸器・補助循環の設定や昇圧薬は増強しない。検査・モニターは最小限	本編 I-2-1
終了する治療	項目ごとに：人工呼吸器、補助循環、除細動機能、血液浄化、昇圧薬、血液製剤、抗菌薬、輸液、人工栄養・水分補給。一部だけ終了・減弱してもよい	本編 I-2-1、別編
心停止時	心肺蘇生を行わない	本編 I-2-1、Q38
苦痛緩和の中身	評価する症状と方法（表情・呼吸回数・RDOS）、使う薬と追加の仕方、抜管の前の準備（§4・§5）	緩和ケア別編

記録と指示の文例（ガイドラインの項目に沿って作った例で、原典の文言ではありません）

×「BSCの方針」「以後は緩和の方針」

○ 記録：「〇月〇日、多職種カンファ（参加者：…）と家族面談（同席：…）で、治療・ケアのゴールを『残された時間を苦痛なく家族と過ごす』とした。続ける：フェンタニル持続と必要時のボーラス、ミダゾラム、口腔ケア。始めない・増やさない：昇圧薬の増量、新たな血液浄化。検査は最小限。終える：人工呼吸器（〇日〇時に抜管予定）、経管栄養（抜管24時間前に終了）、抗菌薬。心停止時：心肺蘇生は行わない。苦痛の評価：表情・呼吸回数・RDOSを〇時間ごと」

○ 家族への言い方：「治療をすべてやめるのではありません。苦しさを取る治療は最後まで続けます。これから続けること、新しく始めないこと、やめることを、一つずつご説明します」

§2 誰がどう決めるか：多職種の検討とSDMの2本柱で

新版の中心は、結論ではなく決め方です。医療・ケアチームが4つの観点で検討し、患者・家族等と話し合って一緒に決めます。誰か一人が決めることはありません。

この章のポイント

1. **苦痛が大きく望む結果につながらないとき、誰でも提起してよい**
2. **4観点を多職種でもれなく話し、全員に発言の機会を保証する**
3. **意思の確認状況で4つに分け、家族等は本人をよく知る人と捉える**

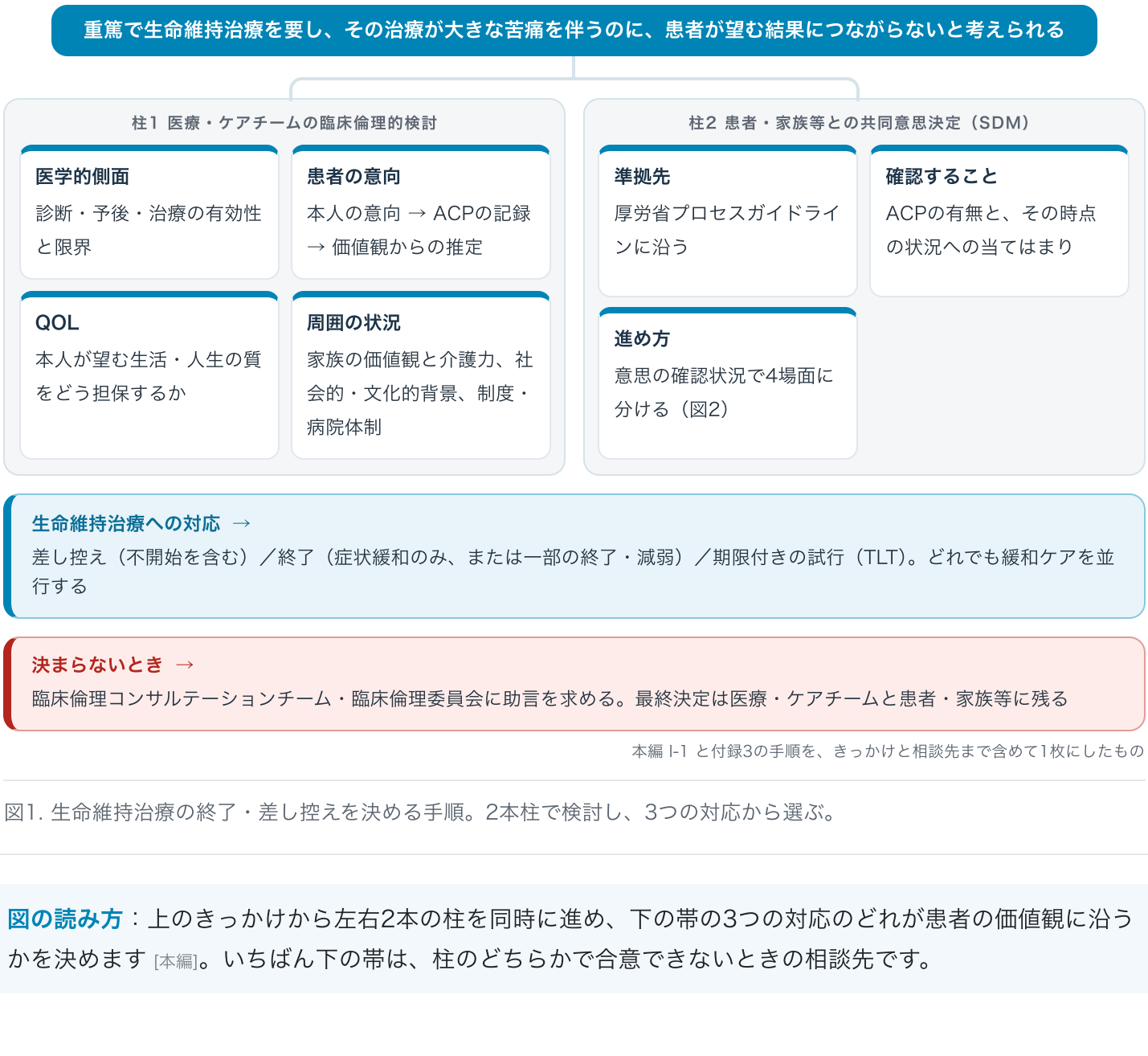


図1. 生命維持治療の終了・差し控えを決める手順。2本柱で検討し、3つの対応から選ぶ。

図の読み方：上のきっかけから左右2本の柱を同時に進め、下の帯の3つの対応のどれが患者の価値観に沿うかを決めます [本編]。いちばん下の帯は、柱のどちらかで合意できないときの相談先です。

2-1. 考え始めるのは「苦痛が大きいのに望む結果につながらない」とき

重篤な状態で生命維持治療を要し、その治療が大きな苦痛を伴うのに患者の望む結果につながらないと考えられるとき、チームは最善の治療・ケアのゴールを見直し、その手段として終了・差し控えを考え始めます [本編]。

提起するのは誰でもかまいません（Q23）。医療者から提案するときは、複数の選択肢と見通しを示し、価値観を十分に聴いて、結論を誘導しないことが求められます。患者本人が終了を希望した場合も、本人の希望だけで決めず、医学的妥当性を含む検討とSDMで判断します（Q54） [Q&A]。

2-2. 4観点を多職種でもれなく話し、全員に発言の機会を保証する（柱1）

臨床倫理的な検討とは、医学的側面・患者の意向・QOL・周囲の状況の4観点をもれなく話し合うことです。検討には、その患者に関わるすべての診療科と多職種、かかりつけ医や在宅の医療・ケア従事者まで加わるのが望ましいとされます [本編]。

これまでゴールは医師の意見で決まりがちでした。新版は、関わる全員に公平な発言の機会を保証し、話し合える心理的安全性を確保することを求めています。医師の方針を追認するだけの形式的な場は趣旨に反します（Q62） [本編] [Q&A]。

- 使える道具：Jonsenの4分割法、臨床倫理検討シート（臨床倫理ネットワーク日本）、臨床倫理の4分割表（E-FIELD）
- 組織の文化で選択肢が偏ることがある。選択肢が適切に示されたか、セカンドオピニオンや倫理コンサルの機会があるか、過程が記録され再評価できるかを確かめる（Q22）
- 多職種での情報共有は必要な範囲に限り、患者・家族等が共有を望む範囲を尊重する（Q28）

2-3. SDMは本人の意思の確認状況で4つに分けて進める（柱2）

SDMは厚労省プロセスガイドラインに準拠し、本人の意思を確認できるか、推定できるか、推定もできないか、身寄りがないかで進め方を変えます（図2） [本編]。

救急・集中治療では本人が意思を示せない場面が多いため、そうなる前から家族等も含めて話し合いを繰り返しておくことが重要です。家族等は法的親族に限らず、本人の価値観をよく知る人を指します [本編] [Q5]。

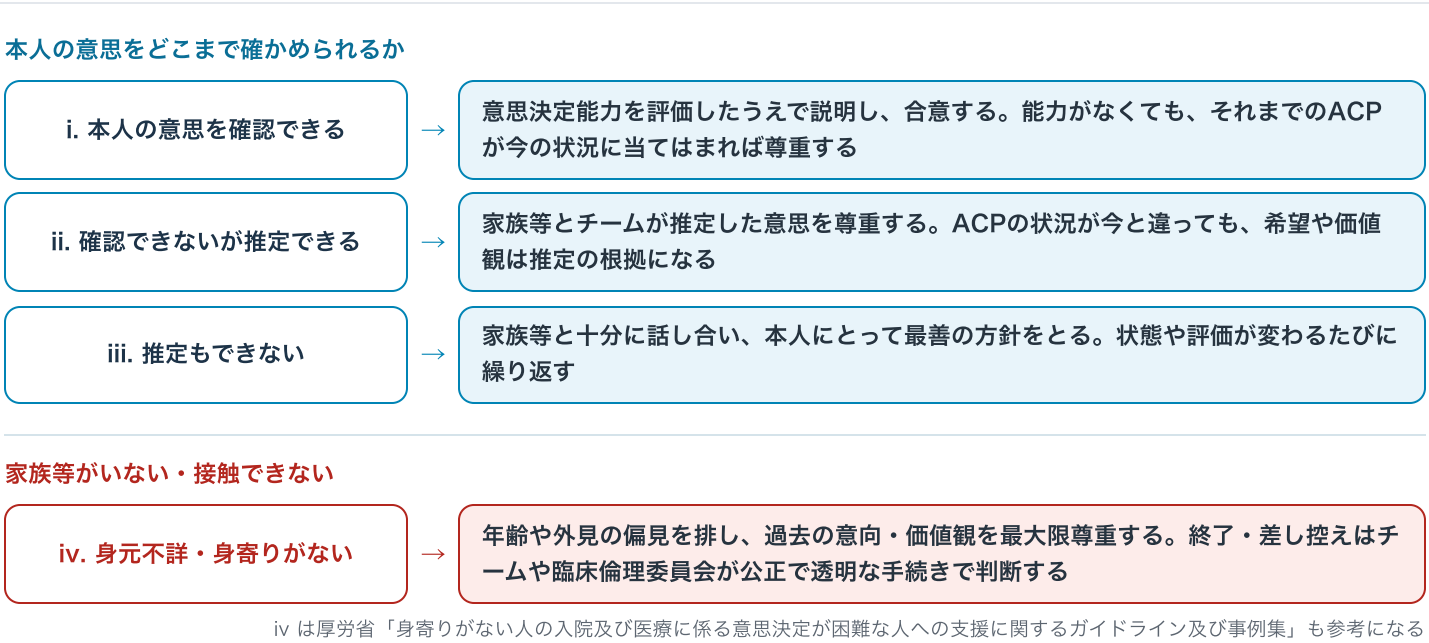


図2. SDMの4つの場面。本人の意思にどこまで近づけるかで進め方を変える。

> **図の読み方**：本人の意思に近い情報があるほど、上の段になります [本編]。どの段でも、最善かどうかは「本人の価値観に即した最善」で判断します。その最善は、第三者が客観的に決める利益ではありません（Q46・Q55）。

2-4. 「家族等」は本人の価値観をよく知る人：法的親族に限らず、複数でもよい

4学会GLの「家族等」は厚労省プロセスガイドラインと同じく法的な親族関係に限られず、本人の価値観や意思をよく知り、意向を推定するうえで重要な役割を果たしうる人を指し、親しい友人や事実上のパートナーも含まれ、一人に限られず複数いることもあります [Q5]。

家族等の役割は、本人に代わって決めることではなく、本人ならどう考えるかを一緒に推し量ることです。そのために必要なのは血縁ではなく、本人の価値観をよく知っていることです。血縁のない人が関わって臨床倫理的検討をすることに何ら問題はなく、ガイドラインに則って行動すれば法的トラブルを招くことは考え難い、とQ&Aは答えています [Q50]。

表5｜「家族等」をめぐる場面：中心に置くのは本人の価値観

場面	ガイドラインの考え方
誰が入るか（例）	配偶者・子・きょうだいなどの親族のほか、親しい友人、事実上のパートナーなど、本人の価値観をよく知る人（Q5）
家族等が複数いる	本人の価値観を中心に据え、関係者の間で丁寧に情報を共有して対話する（Q5）。特定の一人に過度に頼らない（Q26）
家族等の意見が割れる・本人と違う	優先は本人。家族等の意向に経済的負担や年金などの事情が影響していないか（家族等の利益相反）に留意し、本人の価値観を中心に調整する。まとまらなければ臨床倫理コンサルテーション（Q6・Q18・本編）
キーパーソンが判断できない・亡くなった	早くから複数の関係者で情報を共有しておく。すでに得た本人の意思や価値観と、他の関係者の情報をもとに多職種で検討する（Q26）
家族等がいない・接触できない	チームが本人にとっての最善を判断し、過去の意向を最大限尊重する。終了・差し控えはチームや臨床倫理委員会が公正で透明な手続きで判断する（本編 iv）。孤立した患者は診療記録・生活歴・知人や近隣・関係機関から情報を集め、医療ソーシャルワーカーと連携する（Q27）

「家族等」の確かめ方と記録の仕方

1. 本人が話せるうちに「話すことが難しくなったら、どなたに意思を推定して話し合ってほしいですか」と聞く。本人が信頼できる人を指名し、希望を伝えておくことが重要（別編・Q50）
2. 説明の対象となる家族等とその範囲（誰が、本人とどういう関係で関わっているか）を記録する（本編 III）
3. 推定意思は、誰がどんな根拠でそう考えたかと一緒に記録する（本編 III）
4. 情報の共有は必要な範囲に限り、本人と家族等が望む範囲を尊重する（Q28）
5. 家族等に強い決断力を求めず、決定の負担を一人に背負わせない（Q29）

2-5. 迷う場面では、本人の価値観を中心に何度でも話す

家族と意見が違う、「お任せします」と言われる、意思が揺れるといった場面でも、Q&Aの答えは共通しています。その答えは、本人の価値観を中心に置き、一度で決めきらず、決定の負担を一人に背負わせないことです（表6） [Q&A]。

表6｜迷う場面の次の一手：一度で決めきらない

場面	確かめること	次の一手
本人と家族等の意見が違う（Q6・Q18）	優先は本人。家族の意向に介護・経済的負担や年金・保険の事情が影響していないか	家族の意向も大切にしつつ本人の価値観を中心に調整。必要なら第三者の助言
「お任せします」と言われる（Q19）	情報の差が原因ではないか	専門用語を避け、選択肢と利点・不利益を釣り合いよく示し、理解を繰り返し確かめる
意思が揺れる（Q20・Q21・Q29）	揺れは自然なこと	再面談と再評価を前提にする。家族に強い決断力を求めない
時間がなく価値観を引き出せない（Q24）	多職種と家族等からの情報	話す機会を繰り返し確保し、できる限り近づく
キーパーソンが判断できない・亡くなった（Q26）	老老介護などで家族の状況が変わる	早くから複数の関係者で情報を共有し、将来の決め方も話し合っておく
公的支援とつながらない孤立した患者（Q27）	診療記録・生活歴・知人や近隣・関係機関	医療ソーシャルワーカーと連携し、単独で判断しない

2-6. 決まらなければ臨床倫理コンサルへ：助言者であって決定者ではない

チーム内でゴールが決まらない、患者・家族等と合意できない、家族の中で意見がまとまらない、意思が確認できず家族もいないときは、臨床倫理コンサルテーションチームや臨床倫理委員会に検討と助言を求めます [本編]。

役割は、現場の決め方がガイドラインに沿っているかを判断して支えることで、決定を代わりに行うことではありません（Q60）。臨床倫理委員会は、適切なプロセスを踏んだ決定であれば、刑事・民事で訴追されたときにチームを守る役割を持つとされています [本編 注釈2]。

医療安全委員会とは役割が違い、独立して運用するのが望ましいとされます。終了・差し控えは医療事故ではなく、適切なプロセスに基づく医療判断です（Q61） [Q&A]。

§3 選択肢は3つ：差し控え・終了・TLT、どれを選んでも苦痛は取る

手順を踏んで終了・差し控えが妥当と判断されたとき、対応は差し控え・終了・期限付きの試行（TLT）の3つです。どれも生命の短縮を目的とせず、症状緩和の治療とケアは続きます。

この章のポイント

1. 差し控えと終了は倫理的に同じ判断の構造だと知る
2. TLTは目標・再評価の時点・価値観との結びつきを先に決める
3. DNARで決まるのは心停止時の蘇生だけと押さえる

3-1. 差し控えと終了は倫理的に同じで、違うのは時間の順序だけ

治療の倫理的な評価は、始めるか終えるかという順序ではなく「その時点で患者にとって適切か」で決まります。未開始なら差し控え、開始済みなら終了を検討するという判断の構造は同じです（図3） [Q33]。

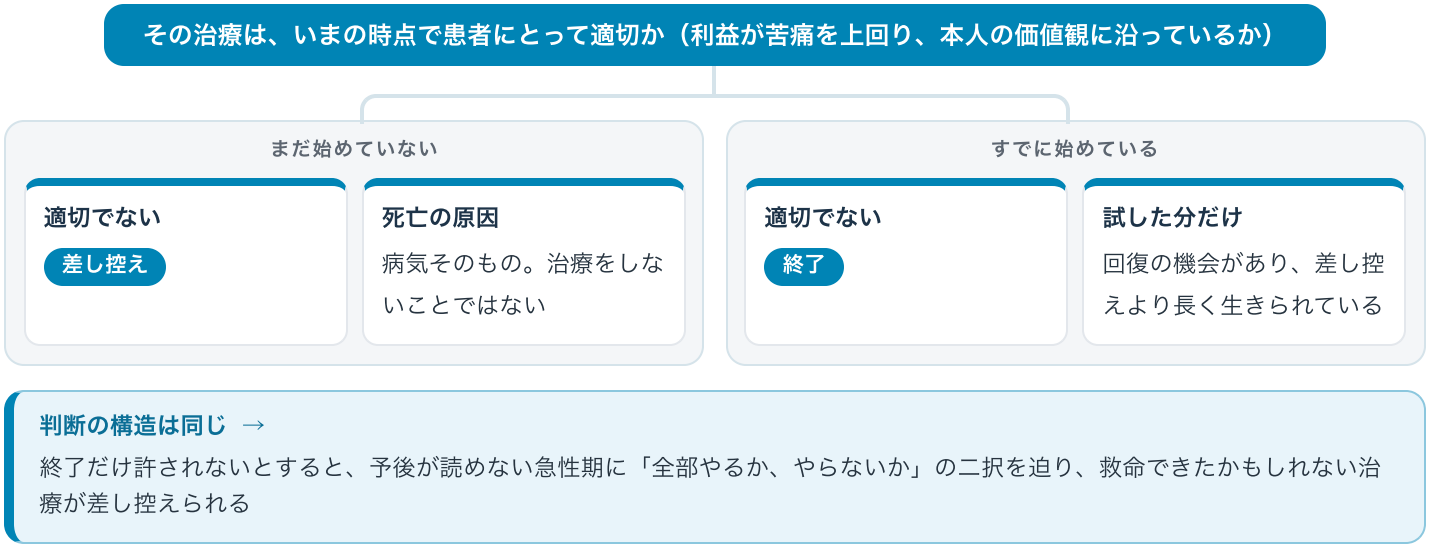


図3. 差し控えと終了は同じ問いへの答え。始めたかどうかで倫理は変わらない。

図の読み方：上の問いは1つで、左右は治療をすでに始めているかどうかの違いだけです [Q33]。下の帯は、終了を差し控えより重く扱うと起きることです。一度始めた治療はやめられるからこそ、迷ったら始めて試すことができます [Q34]。

一度始めた治療を終えることに心理的な抵抗が生じやすいのは事実ですが、心理的な差があっても倫理的な位置づけは変わりません [Q33]。緩和ケア別編は、よくある誤解に次のように答えています [別編]。

- 終了は患者を見捨てることになる → ゴールが苦痛の緩和中心に変わったとき、終了は最善のゴールに適う。見捨てることでも諦めることでもない

- 終了は「善行」に反する → 望まない治療を続けることが苦痛を与えている可能性がある。許容できない負担を与え続ける治療をやめることは善行にあたる
- 差し控えは安全だが終了は危険 → 倫理的に同義。終了だけを避けると、家族に「一度決めたら変えられない」という重圧を与える

3-2. 3つの選択肢で、行うことと行わないことを分けて書く

差し控えでは新たな治療の開始や増強をせず、終了では症状緩和だけにするか一部を終了・減弱し、TLTでは期間を決めて試します。差し控えと終了ではいずれも心停止時に心肺蘇生を行いません（表7） [本編]。

表7｜3つの選択肢：どれを選んでも、症状緩和は最大限続ける

選択肢	行うこと	行わないこと
差し控える（不開始を含む）	症状緩和の治療とケア。生命維持装置の設定や昇圧薬は、減弱できれば減弱する	新たな治療の開始と増強。検査・モニターも侵襲なので最小限に。心停止時の心肺蘇生
終了する：症状緩和だけにする	鎮痛・鎮静薬などは続けて調整する	人工呼吸器・補助循環、ペースメーカー・植込み型除細動器の除細動機能は停止か取り外しを検討。血液浄化・昇圧薬・血液製剤・抗菌薬・輸液・人工栄養と水分補給の終了も検討。心停止時の心肺蘇生
終了する：一部を終了・減弱する	話し合いの結果、項目ごとに続けるか、減らすか、終えるかを決める	心停止時の心肺蘇生
期限付きの試行（TLT）	合意した期間、特定の治療を試し、目標に向かって改善するかを確かめる	期限が来たら自動的に終了すること（3-3）

施設ごとにプロトコルを作るなどして施設全体で取り組むことが望ましいとされます。終了後は短時間で心停止になることもあるので、家族等の立ち会いのもとで行うことも検討します。予測と違う経過や意向の変化があれば、もう一度チームで検討し直します [本編]。適切なプロセスで終了・差し控えを選んだ後に、苦痛を伴う心停止時の心肺蘇生を行うことは推奨されません（Q38）。

3-3. TLTは3点を先に決め、期限で必ず立ち止まる

TLTは、家族とチームの意見が違うときや予後が読めないときに、目標と期間を合意して特定の治療を試す方法です。始める前に、「何を目標に試すか」「いつ何で再評価するか」「その結果が本人の価値観とどう結びつくか」を決めます（図4） [本編] [Q35]。

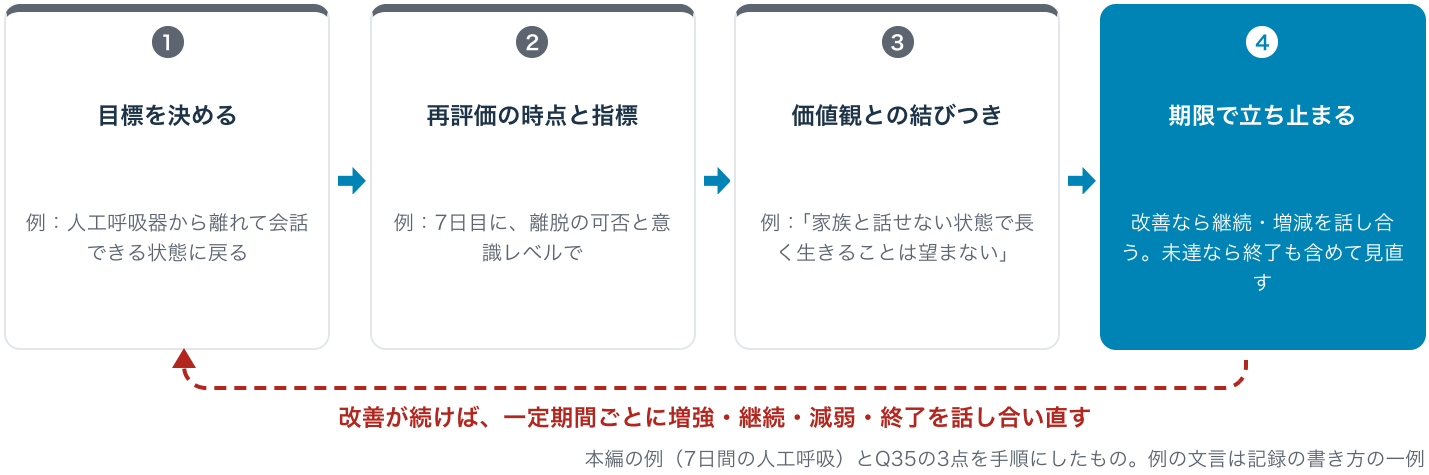


図4. TLTの組み立て。先に3点を書き、期限で必ず立ち止まる。

> **図の読み方**：左の3段は始める前に書くこと、右端が期限の日の判断です [Q35]。期限が来ても自動で終了せず、自動で延長もしません。下の破線が、改善したときに話し合いを繰り返す道です [本編]。

TLTには、予後の見通しが立つ、対立を解くための対話ができる、家族が状況を受け入れる時間ができる、という利点があります。一方で侵襲的な治療の期間が延び「死のプロセスの質」を損なうという欠点もあり、適応と期間に配慮が要ります [本編]。

！注意 — 「決めきれないから続ける」にしない

3点が曖昧なまま続けると、「決めきれないから続ける」「説明が難しいから先送りする」に陥り、ガイドラインの趣旨に反します。多職種で検討したこと自体は結論の正しさを保証しません。判断が本人の価値観やQOLとどう整合しているか、根拠を説明できることが大切です [Q35]。TLTは終了へ誘導する枠組みではありません。在宅療養や福祉サービス（重度訪問介護など）の検討に要る情報も十分に提供します [Q36] [Q78]。

3-4. DNARで決まるのは心停止時の蘇生だけ

DNARは「心停止時に心肺蘇生を行わない」という限定的な指示です。対象は胸骨圧迫・除細動・気管挿管などの心停止時の処置に限られ、それ以外の治療の質や内容を制限しません [Q37]。

○ DNARがあっても行うこと

- 肺炎への抗菌薬
- 呼吸困難への酸素・非侵襲的換気
- 痛みや不安への鎮痛・鎮静
- 脱水への補液

× してはいけないDNARの運用

- 入院時に一律に設定する
- 業務効率や急変対応の簡略化のために設定する
- partial DNAR（胸骨圧迫はするが挿管はしない等）の曖昧な指示

Q39は便宜的・画一的なDNARの運用を「明確に否定」し、DNARは適用範囲が明確であることが不可欠だとしています [Q39]。

3-5. 強心薬・ペースメーカー・人工栄養も、同じ手順で個別に決める

症状緩和に使っている薬は必ずしも減らさず、ペースメーカーや人工栄養も生命維持治療になりうるものとして、同じ手順で一つずつ判断します（表8） [Q&A]。

表8｜個別の治療の扱い：一律に止めず、何のために使っているかで決める

治療	考え方
心不全の苦痛緩和に使っていた強心薬（Q40）	症状の強さと必要性に応じて増減する。必ずしも減量や終了は要らない
ペースメーカー（Q41）	自己脈がほとんどなく依存しているなら事実上の生命維持治療。依存の程度で個別に判断
機械的補助循環（Q42）	対象に含まれ、同じ手順で決める。日本では議論が乏しく経験施設が非常に少ない（4-6）
自発呼吸のない患者の抜管（Q43）	ありうる。考え方は同じだが心停止までが短くなるのが一般的で、事前に家族へ十分に説明する
人工栄養（Q44）	胃ろうを含め生命維持治療の一つ。行わない場合も口腔ケア・食事介助・苦痛緩和は続け、「何もしない」ではない
鎮痛・鎮静で結果的に呼吸が抑制される（Q59）	症状緩和に必要十分な量に調整する。死亡を目的に過量投与すれば安楽死で違法

3-6. 臓器提供は、方針が決まった後に独立した話として示す

臓器提供は亡くなりゆく患者の選択肢の一つです。提供の可能性が終了の判断に影響してはならず、方針が整理された後に独立したプロセスとして提示します [本編] [Q79]。

脳死とされうる状態での脳死下臓器提供は、終了・差し控えの意思決定と切り離せないため、同じ多職種検討とSDMの手順で家族等に情報を提供して話し合います。心停止後臓器提供は、終了・差し控えの意思決定が示された後に、専門家による慎重な医学的適応の

判断のもとで検討します [本編]。提示しないことも、情報に基づいて決める機会を損ないます [Q79]。

§4 終了の実際：チームでそろえ、止めるものを決め、先回りして抜管する

終了が決まったら、まずチームの認識をそろえ、止めるものと残すものを決め、抜管の前に薬と家族の準備を済ませます。この章は緩和ケア別編の手順を時間の順に並べたものです。

この章のポイント

1. **実施前に5つの共通認識と再挿管しないことを確かめる**
2. **経管栄養は24時間前、筋弛緩薬は2時間前に止める**
3. **苦痛が落ち着くまで、医師と看護師はベッドサイドを離れない**

4-1. 始める前に、チームで5つの共通認識をそろえる

チーム内で誤解が生じないよう、実施前に次の5点を繰り返し確認します。あわせて、心停止時に胸骨圧迫を含む蘇生を行わないこと、抜管後に再挿管しないことを医療者の間で再確認します [別編]。

実施前にチームで確かめる5点

1. 生命維持治療は、最善のゴールを達成する選択肢として終了・差し控えできる
2. 終了・差し控えには適切なプロセスを踏む必要がある
3. ガイドラインに沿った終了・差し控えは安楽死とは異なり、法的に問題となる行為ではない
4. 症状緩和が最優先で、適切に薬を使った結果、間接的に死期が早まりうることは許容される
5. 終了・差し控えは患者を見捨てることではない

意見の対立は珍しくありませんが、価値観の対立より、家族への心理的支援の不足やコミュニケーション不足から生じるものが多いとされます。話し合いを重ねると90%以上の事例で治療プランに合意すると報告されています。倫理コンサル、緩和ケアチーム、外来主治医、ソーシャルワーカーの関与が対立の解消に役立ちます [別編]。

4-2. 止めるものと、止めるかを検討するものを分ける

透析・経管栄養・昇圧薬・抗菌薬・輸血・筋弛緩薬・身体拘束は終了し、補助循環やライン、モニター、検査などは苦痛と利益を比べて一つずつ検討します（表9） [別編]。

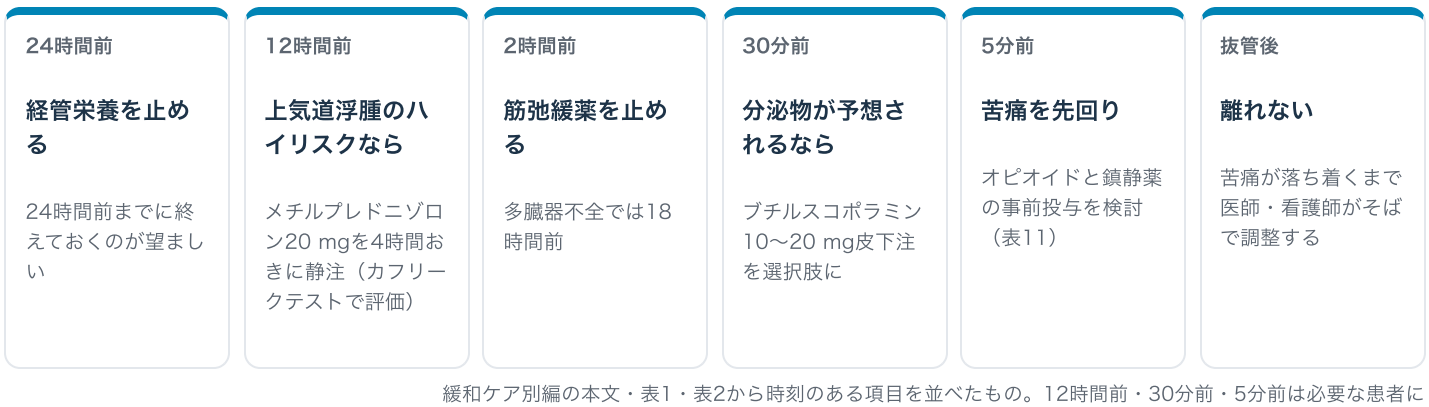
ICUの緩和ケアで最も大事な点は、救命のための医療行為の多くが患者にとって大きな苦痛だと認識することです。頻回の採血のように症状緩和につながらない行為は差し控えを検討し、続けるために身体拘束が要る行為は終了を考えます [別編]。

表9｜止めるもの・検討するもの：観るのは数値ではなく、表情と家族の反応

区分	項目	注意点
終了する	透析、経管栄養、昇圧薬、抗菌薬、輸血、筋弛緩薬、身体拘束	家族等と十分に話して決める
終了を検討する（装置）	機械的循環補助、ペースメーカー、ICDの除細動機能	ICDは循環器内科医と相談して除細動機能の停止（deactivation）を検討
終了を検討する（ライン・モニター）	中心静脈ライン、動脈ライン、心電図モニター、パルスオキシメーター	中心静脈は末梢がなければ投与路として残してよい。モニターは外してもよく、付けるならアラームを切る。モニターを外させないための身体拘束はしない
終了を検討する（ケア・検査）	バイタルサインの測定、輸液、体位変換、血液検査、X線・CT	輸液は浮腫・腹水・胸水・せん妄につながるので終了を検討し、家族に分かりやすく説明する

4-3. 抜管の前日から、時間を逆算して準備する

経管栄養は24時間前まで、筋弛緩薬は2時間前まで（多臓器不全では18時間前まで）に終了しておくことが望ましいです。筋弛緩薬が残っていると、苦痛や不安を評価できず鎮痛を調整できません（図5） [別編]。



緩和ケア別編の本文・表1・表2から時刻のある項目を並べたもの。12時間前・30分前・5分前は必要な患者に

図5. 抜管までの準備。前日から時間を逆算する。

図の読み方：左から右へ時間が進みます。経管栄養と筋弛緩薬の終了と、抜管後にそばにいることは全員が対象です。12時間前・30分前・5分前の投与は、上気道浮腫・分泌物・苦痛の出方を予想して患者ごとに検討します [別編]。

4-4. 抜管は段階的離脱か即時抜管を選ぶ（死亡までは数分から数日）

抜管の方法は、15〜30分かけて設定を下げる段階的離脱（gradual weaning）と、設定を下げずに準備のうえ抜管する即時抜管（immediate extubation）の2つです。高度の呼吸サポートが要る呼吸不全では前者、意識障害の患者では後者が多く選ばれます [別編]。

段階的離脱（gradual weaning）

- 15〜30分かけて呼吸器の設定を下げ、できるだけ自発呼吸へ移す
- 麻薬や鎮痛薬を適量投与しながら行い、そのうえで抜管する
- 高度のサポートが必要な呼吸不全で多い

即時抜管（immediate extubation）

- 設定を下げずに抜管する
- 鎮静・鎮痛の準備を済ませてから行う
- 脳神経疾患などで意識障害がある患者で多い

0.9 時間
抜管から死亡までの中央値（海外の報告）。数時間〜数日の例もある

15〜30 分
段階的離脱で設定を下げる時間

死亡までの時間には幅があるので、家族には不確実性を含めて説明し、状態が変わるたびに伝えます [別編]。浮腫・外傷・腫瘍で気道閉塞のリスクが高い場合は、本人・家族の意向によって、人工呼吸は終了しても気管チューブは残す選択肢があります [別編]。自発呼吸がない患者の抜管もありえますが、心停止までがより短くなります（Q43）。

4-5. 家族には経過・支え・別れの時間の3つを先に用意する

家族には、終了後に呼吸や循環がどう変わるかを具体的に説明して、心の準備を促します。看護師（可能なら心理職やソーシャルワーカー）が心理的に支えます。別れを告げ、思い出を振り返る時間と環境を確保します [別編]。

立ち会いを望まない家族には一度退室してもらい、苦痛が抑えられたことを確かめてからすぐに入室してもらいます。気道狭窄や喘鳴が出たら対応すること、ケアは続くことも先に伝えておきます（6-2） [別編]。

4-6. 機械的補助循環では、TLTの期限と機械側の事象で終了を考えている

IABP・ECMO・IMPELLA・植込み型LVADの終了は日本では知見が乏しく、実際にはIMPELLAやLVADの血栓閉塞、ECMOの人工肺の機能低下が終了の条件になっています。別編は、TLTを当てはめ、期間内にゴールが達成できないと考えられたときに終了を検

討するよう勧めています [別編]。

- 昇圧薬などは緩和的な治療として続けることが多い。末期状態でないのに植込み型LVADの停止を強く求められるなど、チームで判断できないときは臨床倫理委員会で妥当性を検討する
- 鎮痛は静注オピオイド（フェンタニル、モルヒネ）が第一選択。鎮静はミダゾラム、プロポフォール、デクスメデトミジンが一般的
- TLTの期間はベンゾジアゼピン以外が好ましい可能性がある（人工呼吸期間とICU滞在の延長の報告）。循環が不安定ならミダゾラムが使いやすい場合もある

§5 症状緩和の薬：先回りし、ボーラスで効かせ、上限を設けない

終了・差し控えの後も、症状緩和の治療は最大限続きます。本編は、適切な緩和ケアを提供できない状態で終了・差し控えを行うべきではないと明記しました。この章で扱うのは、緩和ケア別編の薬の使い方です。

この章のポイント

1. **緩和ケアは終了の後ではなく、搬送・入室の早期から始める**
2. **呼吸困難と痛みにはオピオイドをボーラスで、上限を設けない**
3. **持続投与中なら、抜管直前に直近量に比例して上乗せする**

5-1. 緩和ケアは終了の後ではなく、救急搬送・ICU入室の早期から

主治医や担当看護師などのプライマリ・チームが日常の診療として行う「基本的緩和ケア」（症状緩和・意思決定支援・心理社会的支援）を早期から提供し、緩和しにくい苦痛や意思決定の困難があれば緩和ケアの専門家と連携します [本編]。

終了・差し控えの後に緩和ケアを導入するのでは遅すぎます。救命治療と苦痛の軽減は対立するものではなく両輪です。痛み・呼吸困難・不安への対応は治療の有効性や安全性にも寄与します（Q57・Q58） [本編]。

× 危険 — 緩和ケアの準備なしに終了しない

侵襲的な治療を終えても症状緩和の治療は最大限続くので、適切な緩和ケアを提供できない状態で終了・差し控えを行うべきではありません [本編]。「BSC」のように中身の見えない言い方は「もう治療はしない」「見放された」と受け取られやすいため、使わないことになりました [説明文]。

苦痛の評価は、本人が答えられればESAS-r-JやIPOS患者評価用、答えられなければIPOSスタッフ評価用を使います。意思表示できない患者の呼吸困難はRDOS（表12）を補助にします [別編]。

5-2. 薬の原則は必要十分・定期評価・柔軟・オピオイドに上限なしの4つ

鎮痛・鎮静薬は苦痛が緩和されるのに必要十分な量を使い、定期的に評価して調整し、予想に反して長く生存したら減量も含めて見直し、オピオイドには用量の上限を設けません [別編]。

- 過少投与で苦痛を残すことも、過量投与で過度に鎮静することも避ける。深い鎮静でも苦痛の評価を怠らない
- 死亡まで機械的に鎮静を続けるのは適切ではない
- 疼痛・呼吸困難にはオピオイドを、効果がある限り症状が緩和されるまで増やす。効果がなければ増やさず、鎮静薬などの追加を考える
- がん・非がんを問わない。一部の薬には保険適用外の使い方が含まれ、施設の方針を参考に担当医の裁量と責任で使う

終了時の症状コントロールは、質の高いエビデンスが乏しく、経験と専門家の合意に基づいています [別編]。下の用量は一例で、体重・年齢・病状・臓器障害で調整します。

5-3. 初回量の目安：オピオイド未投与ならモルヒネ2〜5 mgのボーラスから

呼吸困難と痛みにはオピオイドが最も有効とされ、効果が早く蓄積しにくい「ボーラス・ファースト」が支持されています。オピオイド未投与ならモルヒネ2〜5 mgを1回量とし、高齢で衰弱した人ではさらに少なくします（表10） [別編]。

表10｜症状別の初回量：まず少量をボーラスで、効くまで刻む

症状	薬	初回	追加・続け方	効き始め
呼吸困難・痛み（オピオイド未投与）	モルヒネ	**2〜5 mg 静注／皮下**	10〜15分ごとに1〜2時間量を早送り。持続は5〜10 mg/日から	**静注2.5〜5分**
同上	フェンタニル	**20〜50 μg 静注／皮下**	5〜10分ごとに0.35〜0.5 μg/kgを反復。安全域が狭いので少量ずつ	**静注1〜2分**
同上	オキシコドン／ハイドロモルフォン	**2〜5 mg／0.16〜0.4 mg**	10〜15分ごとに1〜2時間量を早送り	**静注5分**
呼吸困難・痛み（オピオイド投与中）	使用中のオピオイド	**1〜2時間量か頓用の有効量**	—	—
不安	ミダゾラム	**0.01〜0.06 mg/kgを1分以上かけて**	5分以上あけて0.03 mg/kgを追加。総量0.3 mg/kgまで	**1〜2分**
せん妄	ハロペリドール	**2.5〜5 mg**	10 mg/日まで	**3〜20分**
気道分泌物	ブチルスコポラミン	**20 mg 皮下／筋注**	1日数回、または20〜60 mg/日を持続	**30分**
吸気性喘鳴（上気道浮腫の予防）	メチルプレドニゾロン	**20 mg 静注**	抜管12時間前から抜管まで4時間おき	**4時間以上**

緩和ケア別編の表1は、米国救急医学レジデント協会（EMRA）の実務記事を改変したものです。表1は主に単回投与の目安で、すでに持続投与している患者については、表11のように直近の投与量を基準にした上乗せが示されています。悪心・嘔吐（メトクロプラ

ミド、オンダンセトロンなど）とその他の吸入薬は原典の表1を参照してください [別編]。

5-4. 持続投与中なら、抜管直前に直近量に比例して上乗せする

人工呼吸を終了すると直後から強い苦痛が出ることがあるので、呼吸や気道を人工呼吸器に頼っている患者では、抜管の前にオピオイドと鎮静薬をあらかじめ投与することを考えます（表11） [別編]。

本来、鎮静薬は適切な症状緩和薬を使っても症状を抑えられないときだけ使うものです。ただしベンゾジアゼピンは不安やせん妄の症状緩和薬でもあるため、実際には最初からオピオイドと併用されることが多いとされます [別編]。

表11｜抜管の直前・直後の上乗せ（死亡までが短い、または直後に苦痛が出ると予想されるとき）：基準は直近の量

薬	持続中：抜管直前	持続なし：抜管直前（例）	抜管後（持続中）	抜管後（持続なし）	頻回にボーラスが要るとき
モルヒネ	直近の効果量の2倍をボーラス	**5分前に5 mg**	10〜15分ごとに追加ボーラス	10分ごとに呼吸困難・痛みに応じて追加	持続中は速度を25〜50%増。持続なしなら持続を始める
フェンタニル	直近1時間量の25〜50%をボーラス	**5分前に25〜100 μg**	5〜10分ごとに追加ボーラス	5〜10分ごとに50〜100 μgを追加	同上
ミダゾラム	持続の1時間量をボーラス	**5分前に2〜4 mg**	直近の0.5〜1時間量を5〜10分ごとに追加	5〜10分ごとに不安・呼吸困難に応じて2〜4 mgを追加	同上

新しく持続投与を始めるときは、症状を抑えるのに要したボーラス量の半分から始めます（例：モルヒネ2 mgで緩和したら1 mg/時） [別編]。抜管後は、呼吸困難などの苦痛が十分に緩和されたと確認できるまで、医師と看護師はベッドサイドを離れずに観察し、薬を調整します。状態が安定して余命が見込まれれば、減量も考えます [別編]。

5-5. 症状ごとの初手：分泌物は浅く吸い、不安にオピオイドで眠らせない

別編の初手は、呼吸困難・痛みにはオピオイドのボーラス、不安にはミダゾラム、過活動型せん妄には抗精神病薬です。気道分泌物は体位と輸液の減量から始め、上気道狭窄はカフリークテストで先に読みます（図6） [別編]。

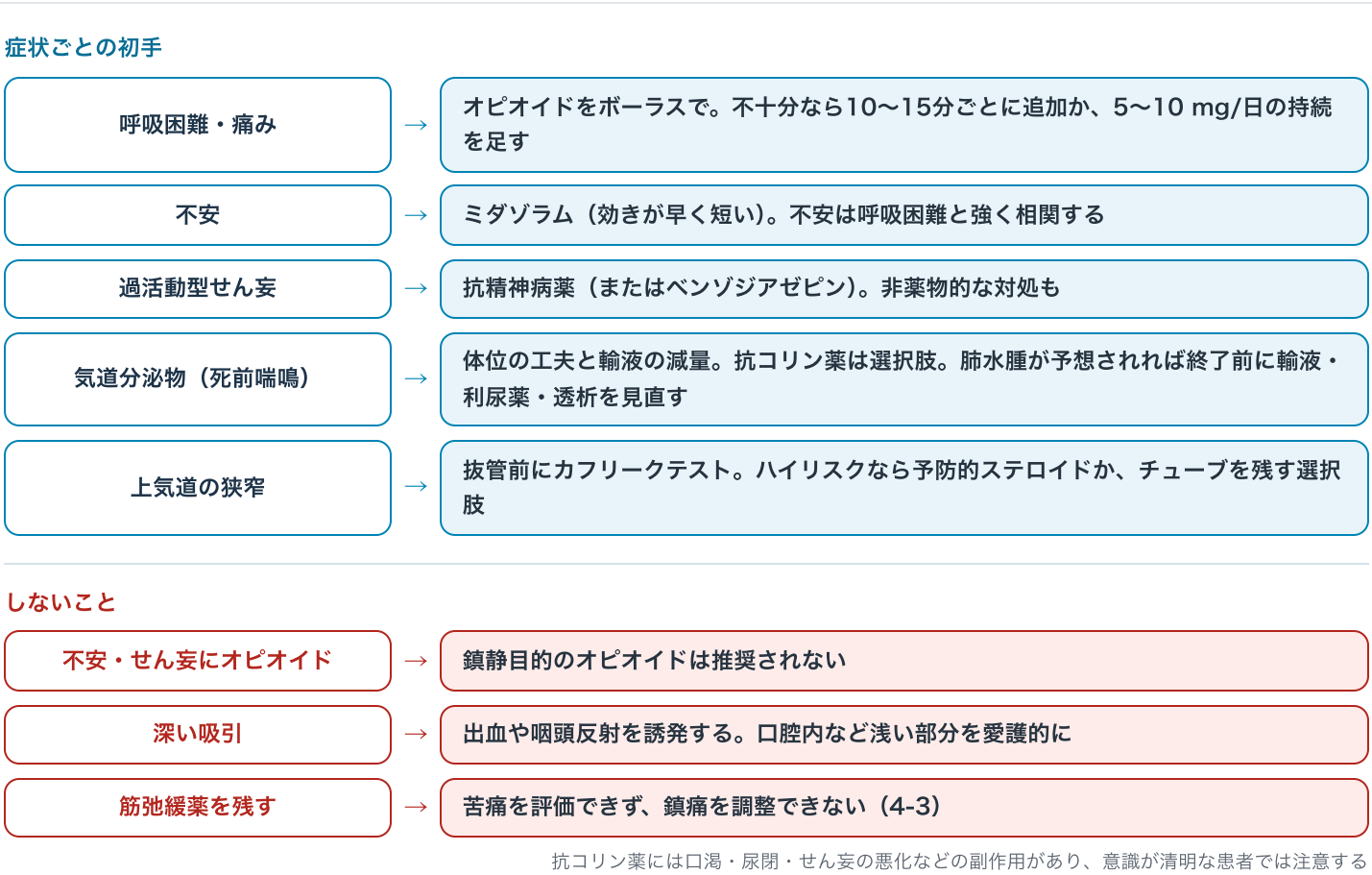


図6. 症状ごとの初手としないこと。予測して先に手を打つ。

図の読み方：上の5段が症状ごとの最初の一手、下の赤い3段がしないことです [別編]。死前喘鳴は本人の苦痛ではないとする見解もありますが、そばにいる家族の苦痛になることが多いので、家族への説明も初手に含めます。

根拠を見る（表12：日本語版RDOS）

意思表示できない患者の呼吸困難は、日本語版RDOSで客観的に補助評価できる可能性があります。終了後はバイタルサインが異常値になり、せん妄もあり、モニターを外していることもあるので、表情・仕草・家族の評価を加えて総合的に判断します [別編]。

表12｜日本語版RDOS（Respiratory Distress Observation Scale）：自己申告の代わりにはならない

項目	0点	1点	2点
心拍数（回/分）	89以下	90〜109	110以上
呼吸回数（回/分）	18以下	19〜30	31以上
落ち着きのなさ（合目的でない動き）	無	時々軽微な動き	頻繁な動き
奇異呼吸（吸気時に腹部が陥没）	無	—	有
呼吸補助筋の使用（肩呼吸）	無	わずかに上昇	著しく上昇
呼気終末の呻吟	無	—	有
鼻翼呼吸	無	—	有
苦悶表情	無	—	目を見開く・顔面の緊張・眉間の皺・開口・歯を食いしばる（どれか1つ）

成人用。筋弛緩薬で麻痺している患者には使えない。心拍数と呼吸回数は1分間数える（Sakuramoto, PLoS One 2021 の日本語版） [別編]。

§6 家族と医療者を支える：話し合いの型と、6つの時期のケア

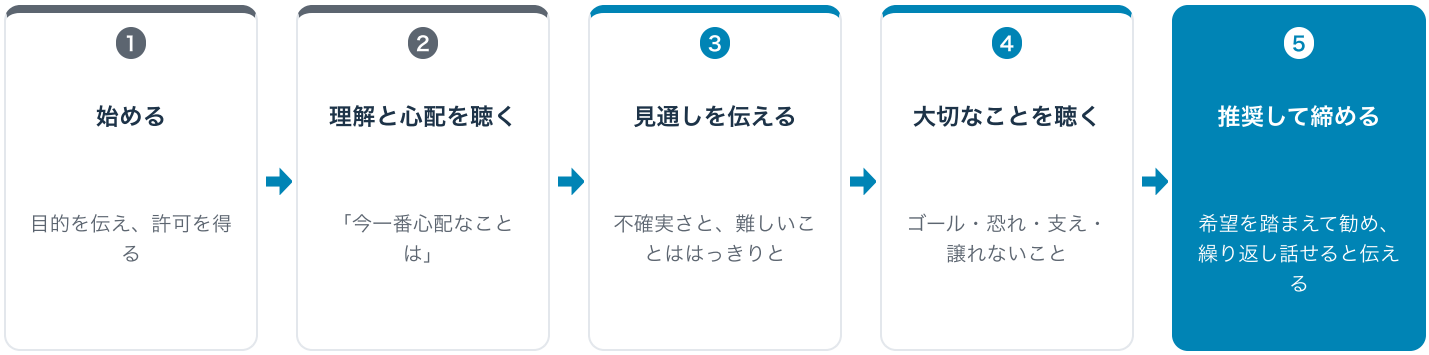
終了・差し控えをめぐる話し合いは、家族にとっても医療者にとっても重い経験です。別編は、話し合いの進め方、時期ごとの家族のケア、医療者を組織で支える方法を具体的に示しています。

この章のポイント

1. **説明の前に、理解と大切なことを聴く**
2. **家族のケアは話し合いの前から死別後まで6つの時期で考える**
3. **医療者のモラルディストレスは組織で支える**

6-1. 話し合いは「聴く」から始め、推奨は最後に伝える

別編の話し合いの型は、目的を伝えて許可を得る、理解と心配を聴く、見通しを伝える、大切なことを聴く、推奨を伝えて締めくくる、の5段階です。医療側が一方的に説明を始めないことが要です（図7） [別編]。



緩和ケア別編 第1章の話し合いの進め方を5段にしたもの。言い方の例は表13

図7. 話し合いの5段階。説明の前に聴き、推奨は最後に。

図の読み方：灰色の2段は医療者が話す前に相手の受け止めを知る段で、ここを飛ばすと説明が届きません [別編]。最後の段の推奨は、4段目で聴いた本人の言葉を引用して組み立てます。

表13｜話し合いの言い方の例：本人の言葉を拾って、推奨につなげる

段階	言い方の例
始める	「今後予想されることをお伝えし、あなたにとってどのようなことが大切かをお聞きしながら、これからの治療やケアの方向性について一緒に考えていきたいと思うのですが、よろしいでしょうか？」
理解と心配を聴く	「今一番心配になられていることはどのようなことですか？」「病状について、どのようにとらえておられますか？」
見通しを伝える	「そうでないとよいのですが、残された時間が日単位〜週単位くらいになってきている可能性があることを心配しています」
大切なことを聴く	「あなたにとってとても大切で、これができないまま生きていくのは考えられない、と思うのはどんなことですか？」「普段の生活で一番楽しみにしていることはなんですか？」「もしお話しすることが難しくなった場合、どなたに、あなたの意思を推定して話し合ってほしいですか？」
推奨して締める	「〇〇がとても大切だとおっしゃいましたね。それを考慮に入れると、現在の病状では◎◎をお勧めします」「この方針をどう思われますか？」

準備では、静かな部屋で参加者を確認し、説明者が正面に座るなら看護師などは患者・家族と説明者の間（90度の位置）に座ります。心情を打ち明けられたら「わかります」と即答せず、沈黙をおきます。感情への応答にはNURSE（命名・理解・承認・支持・探索）などが使えます [別編]。本編は、救急・集中治療の医療・ケア従事者がSDMのコミュニケーションスキルの研修を受けることを推奨しています [本編]。

6-2. 家族のケアは、話し合いの前から死別後まで6つの時期で考える

ICUや救急外来での死別は悲嘆を長引かせるリスクが高いため、別編は家族のケアを話し合いの前・間・後、終了前、臨終時、死別後の6つの時期に分けています（図8） [別編]。

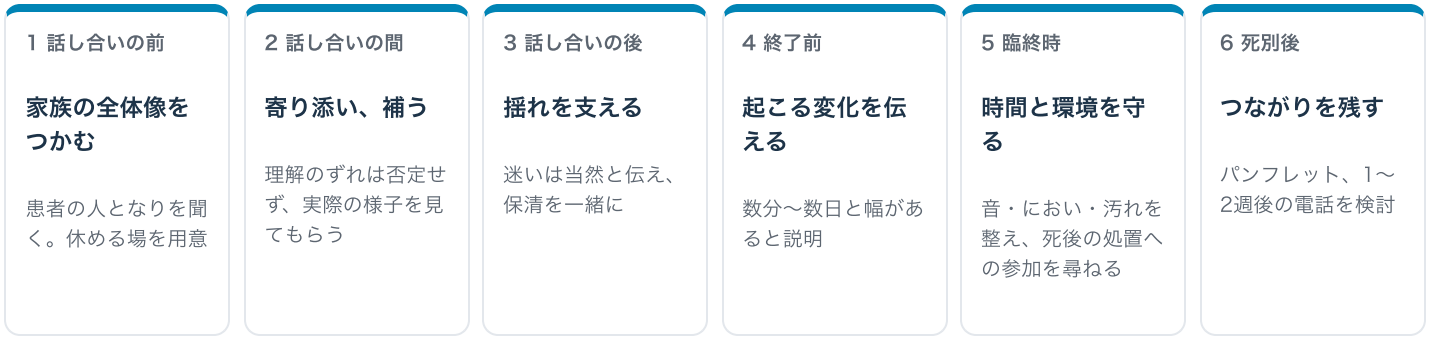


図8. 家族のケアの6つの時期。決める前から、亡くなった後まで。

> **図の読み方**：左から時間が進みます。基盤は日本集中治療医学会「集中治療領域における終末期患者家族のこころのケア指針」（2011）の、権利擁護・苦痛緩和・信頼関係・情報提供・ケアへの参加の5つです [別編]。

表14｜残された時間のケアの例：その人らしさと、家族とのつながりを支える

種類	例
本人を尊重するケア	好きな衣服・帽子・布団や枕、好きな音楽やアロマ、入浴・洗髪・マッサージ、思い出の写真、誕生日や記念日のお祝い、好きな飲み物を味わう、口腔ケアと保湿
家族とのつながり	面会のルールを柔軟に、可能ならペットとの面会、電話やビデオ通話、家族への手紙づくりの支援、保清への家族の参加（顔への送風で呼吸困難が和らぐことがあると伝え、うちわや小型扇風機で家族から風を送ってもらう）
死後を見すえたケア	希望があれば集合写真、手形や髪の一部を形見に、遺言・葬儀・相続などの気がかりを専門家へつなぐ、臓器提供の意思があれば相談窓口へ

6-3. 医療者のモラルディストレスは、個人の耐性ではなく組織で支える

終了・差し控えに関わる医療者には、モラルディストレス・共感疲労・二次的外傷性ストレス・バーンアウトが起こりうるため、別編はセルフケアに加えて、人員配置・デブリーフィング・定期的なスクリーニングなどの組織的な支援を求めています [別編]。

モラルディストレスは、正しいと信じることが他者の価値観や組織の制約で実行できないときの不満・怒り・失望です。特に看護師が経験しやすいとされます。患者の価値観を尊重した決定に対してモラルディストレスを抱える職員への配慮も、組織的支援に含まれています [別編]。

組織として用意するもの

1. 適切な人員配置と仕事量の管理
2. チームワークとコミュニケーションを促す職場環境、レジリエンスの研修
3. 困難な事例の後のデブリーフィング
4. スタッフの心理状態の定期的なスクリーニング（日本語版の尺度：モラルディストレスはMMD-HP、バーンアウトはMBI-GS・BAT-J・JBS など）
5. 緩和ケアチーム・倫理委員会・相談窓口と連携したカンファと相談の体制

§7 記録と法的な位置づけ：経緯を残すことが患者とチームを守る

日本には終了・差し控えを定めた法律がありません。だからこそ、ガイドラインに沿った手順を踏み、その経緯を記録に残すことが拠り所になります。

この章のポイント

1. **説明・意思・検討の3群の項目をそのたびに記録する**
2. **有罪になったのは死期を早める薬を使った事例だった**
3. **適切なプロセスなら違法とされないが、免責ではない**

7-1. 記録は説明・本人の意思・終了を検討した経緯の3群

意思決定のプロセスは経緯を含めてすべて診療記録に記載し、のちに検証を受けても、ゴールの決定と診療の過程が倫理的に妥当だったといえる書き方にします（表15） [本編]。

表15｜診療記録に書く項目：「誰が加わり、何を根拠に」を残す

区分	記載する事項
医学的な検討とその説明	① 説明の対象となる患者・家族等とその範囲 ② 説明した内容 ③ 理解や受容の状況 ④ 同席した医療・ケア従事者
患者の意思	① 本人の意思、またはACPの記録などに示された意思と、それが述べられた状況 ② それがない・不明なら、家族等による推定意思とその根拠
終了・差し控えを検討する際の対応	① 本人の意思またはACPの内容 ② 家族等による推定意思とその根拠 ③ 家族等の意向 ④ 終了・差し控えを考慮する時期であることとその根拠 ⑤ 最善のゴールについての検討内容 ⑥ 検討に加わったすべてのメンバー

意思は時間の経過や心身の変化で変わりうるので、話し合いはそのつど繰り返し、内容を記録します [本編]。コミュニケーションそのものも職務として記録します（Q15）。形骸化を防ぐためのケースレビューや倫理委員会によるプロセス評価、死別後の家族の受け止めを踏まえた評価は、今後の課題とされています（Q31・Q63）。

7-2. 有罪になった2件は、死期を早める薬を使っていた

説明文が振り返る4つの事件のうち、有罪の2件は塩化カリウムや筋弛緩薬で死期を早めた事例でした。不起訴の2件は、意図的な行為はなかったものの、許容される終了かどうかが不明瞭で警察が介入した事例でした [説明文]。

> 根拠を見る（表16：4つの事件）

表16｜終末期医療をめぐる4つの事件：分かれ目は意図的に死期を早めたかどうか

事件	経過	司法判断
東海大学病院事件（1991）	多発性骨髄腫の末期。家族の求めで点滴などを外し、ジアゼパムの後、ベラパミルと塩化カリウムを静注して死亡	1995年 横浜地裁で殺人罪（懲役2年・執行猶予2年）。傍論で、治療終了が許される要件（回復の見込みがなく死が避けられない末期状態／中止を求める意思表示。推定意思でもよい）を示した
川崎協同病院事件（1998）	喘息発作の心停止後の昏睡。家族の求めで抜管し、苦悶様呼吸に鎮静薬、さらに筋弛緩薬を投与して死亡	2009年 最高裁が上告を棄却し有罪が確定。回復可能性や余命を判断できず推定意思にも基づかないので許されないとした。推定意思に基づく終了が許される場合を認め、末期状態に限定しないと解しうる
射水市民病院事件（2000〜2005）	終末期のがん等の患者7名の人工呼吸器を外し、書類送検	2009年 不起訴（死期を早める行為ではない、因果関係に疑問、殺意なし）
道立羽幌病院事件（2004）	誤嚥による心肺停止の蘇生後、本人の意思を確認せず、家族への説明も不十分なまま人工呼吸器を外した	書類送検後、因果関係が認められないとして不起訴

横浜地裁の要件は判決の結論に必要でない「傍論」で、最高裁が追認したものではありません。生命維持装置が動いている限り「死が避けられない末期状態」にはならないため、この要件をそのまま使うと尊厳を損なう治療が続きます [説明文]。

7-3. 適切なプロセスなら違法とされないと考えられるが、免責ではない

2007年以降、救急・集中治療の終末期医療で刑事事件や警察の介入が全国的に報道された例は確認されておらず、ガイドラインに沿った適切なプロセスを踏んでいれば、終了・差し控えが刑事裁判で違法とされることはないと考えられる、と説明文は述べています [説明文]。

ガイドラインは、法的な強制力はないものの社会が法に準じて従う規範（soft law）として働きます。Q&Aは、ガイドラインに沿って適切に行われた終了・差し控えが同意殺人罪や自殺幇助罪にあたることはないと考えられ、通常は警察介入の対象にならないと考えられるとしています。一方で、従えば法的に免責されるとは書いていません [Q48] [Q52]。逆に、ガイドラインに即さない形で行えば批判に耐えられない可能性があります [説明文]。

7-4. 障がい・小児・医療資源：終了の対象を広げるものではない

Q&Aの後半は、障がいのある人や医療的ケアを受けて暮らす人、小児、医療資源をめぐる懸念に答え、ガイドラインが「治療を止める基準」ではないことを繰り返し明言しています（表17） [Q&A]。

表17｜対象をめぐる懸念への答え：手続きと対話こそが不適切な判断を防ぐ

論点	ガイドラインの立場
障がい・医療的ケアを受けて暮らす人（Q70〜Q76・Q80）	障がいの有無や医療機器の使用だけを理由に終了・差し控えを検討することはない。外見や機能からQOLや価値を推し量らない。在宅療養・重度訪問介護などの情報提供を意思決定の前提に置く
推定意思で早く終了されるのでは（Q77）	終了を広げる目的ではなく、適切なプロセスを経ずに方針が決まることを防ぐ枠組み
医療資源・経営（Q47・Q71）	ベッド状況・経営・収益性・「無益性」を判断の根拠とする枠組みは採らない
優生思想（Q56）	特定の人々の生の価値を一般的に評価するものではない
小児（Q67〜Q69）	年齢制限はないが、日本小児科学会「重篤な疾患を持つ子どもの医療をめぐる話し合いのガイドライン（2024年改訂版）」に則る。別編の多くは成人向けで、薬は年齢・体重・発達段階で調整する

令和6年度の診療報酬改定で、意思決定支援に関する指針の作成が入院基本料の要件になりました。本ガイドラインの手順は厚労省プロセスガイドラインに準じているため、各施設の指針作成の参考になるとされています [説明文]。

§8 付録：どう作られ、どこに限界があるか

このガイドラインは臨床試験のエビデンスをGRADEで格付けした診療ガイドラインではなく、専門家の合意で手順を示した臨床倫理のガイドラインです。使うときに知っておきたい作り方と限界をまとめます。

8-1. 修正デルファイ法の3ラウンドで、全項目が合意に達した

4学会から選ばれた多職種の作成委員・アドバイザー35名（デルファイ参加は28名）が、3回のアンケートを行いました。9段階の尺度で70%以上が7〜9と評価した項目を合意とし、全項目の合意を得た後にパブリックコメントを経て確定しました [本編]。

委員には医師・看護師のほか倫理学と法学の専門家が含まれ、患者・家族の代表は含まれていません（Q9）。議論が集中したのは「生命維持治療の一部を終了または減弱する」（コメント34件）とTLT（31件）でした。最終ラウンドの賛成率が最も低かったのは「患者の意思が確認できる場合」（82.1%）でした [本編 付録2]。緩和ケア別編は日本緩和医療学会の委員が起案し、Q&A集はパブリックコメントを反映して整理されたもので、デルファイの対象外です。

8-2. 使うときの注意：推奨の強さは付かず、用量は海外の実務記事が元

推奨の強さもエビデンスの確実性も付いていません。このプロセスで患者・家族のアウトカムや意思決定の質が改善するかについては、実証的なエビデンスが乏しいと著者自身が認めています（Q10） [Q&A]。

- 別編の薬剤表は米国の救急医学の実務記事を改変したもので、日本の用量の根拠ではない。持続投与中の患者では表11のように直近量を基準にする
- 抜管から死亡まで中央値0.9時間は北米の単一の報告。家族に伝えるときは「海外の報告では」と添える

- 筋弛緩薬を2時間前（多臓器不全では18時間前）までに止める数値の根拠は本文に示されていない
- 機械的補助循環の終了については、経験が乏しいことを認めるにとどまり、手順は示されていない
- 法的な安心の根拠は「2007年以降、報道された刑事事件や警察介入が確認されていない」という観察で、法的な免責ではない

主要文献

本文中の［ ］は出典です。本編・説明文・Q&A（Q番号）・別編は、下の1のガイドラインの各分冊を指します。

1. 日本集中治療医学会・日本救急医学会・日本循環器学会・日本緩和医療学会 編. 救急・集中治療における生命維持治療の終了／差し控えに関する4学会合同ガイドライン（本編・説明文・Q&A集・緩和ケア別編）. 令和8年9月.
2. 日本集中治療医学会・日本救急医学会・日本循環器学会. 救急・集中治療における終末期医療に関するガイドライン ～3学会からの提言～. 2014.
3. 厚生労働省. 人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン（解説編）. 平成30年3月.
4. 厚生労働省. 身寄りがない人の入院及び医療に係る意思決定が困難な人への支援に関するガイドライン及び事例集.
5. Gattrell WT, Logullo P, van Zuuren EJ, et al. ACCORD (ACcurate COnsensus Reporting Document): a reporting guideline for consensus methods in biomedicine developed via a modified Delphi. PLoS Med. 2024;21:e1004326.
6. Jonsen AR, Siegler M, Winslade WJ. Clinical Ethics: A Practical Approach to Ethical Decisions in Clinical Medicine. 9th ed. McGraw-Hill; 2021.
7. Hwang DY, Oczkowski SJW, Lewis K, et al. Society of Critical Care Medicine Guidelines on Family-Centered Care for Adult ICUs: 2024. Crit Care Med. 2025;53:e465-82.
8. Kruser JM, Ashana DC, Courtright KR, et al. Defining the Time-limited Trial for Patients with Critical Illness: An Official American Thoracic Society Workshop Report. Ann Am Thorac Soc. 2024;21:187-99.
9. Downer K, Gustin J, Lincoln T, et al. Communicating About Time-Limited Trials. Chest. 2022;161:202-7.
10. Igarashi Y, Tanaka Y, Ito K, et al. Current status of palliative care delivery and self-reported practice in ICUs in Japan: a nationwide cross-sectional survey of physician directors. J Intensive Care. 2022;10:18.
11. Ito K, George N, Wilson J, et al. Primary palliative care recommendations for critical care clinicians. J Intensive Care. 2022;10:20.
12. 日本緩和医療学会. 緩和ケアチーム活動の手引き（追補版）救急・集中治療領域の緩和ケア. 2025.
13. 日本集中治療医学会. 集中治療領域における終末期患者家族のこころのケア指針. 2011.
14. Downar J, Delaney JW, Hawryluck L, et al. Guidelines for the withdrawal of life-sustaining measures. Intensive Care Med. 2016;42:1003-17.
15. Cooke CR, Hotchkin DL, Engelberg RA, et al. Predictors of time to death after terminal withdrawal of mechanical ventilation in the ICU. Chest. 2010;138:289-97.
16. Cassone M, Stoltzfus G, Melnychuk E. Terminal Extubation in the ED: Palliative Care in EM. EMRA (Emergency Medicine Residents' Association). 2020.
17. Sakuramoto H, Hatozaki C, Unoki T, et al. Translation, reliability, and validity of Japanese version of the Respiratory Distress Observation Scale. PLoS One. 2021;16:e0255991.
18. van Esch HJ, van Zuylen L, Geijteman ECT, et al. Effect of prophylactic subcutaneous scopolamine butylbromide on death rattle in patients at the end of life: the SILENCE randomized clinical trial. JAMA. 2021;326:1268-76.
19. Kuriyama A, Umakoshi N, Sun R. Prophylactic corticosteroids for prevention of postextubation stridor and reintubation in adults: a systematic review and meta-analysis. Chest. 2017;151:1002-10.
20. Azoulay E, Timsit JF, Sprung CL, et al. Prevalence and factors of intensive care unit conflicts: the Conflicus study. Am J Respir Crit Care Med. 2009;180:853-60.

21. Kentish-Barnes N, Chevret S, Valade S, et al. A three-step support strategy for relatives of patients dying in the intensive care unit: a cluster randomised trial. Lancet. 2022;399:656-64.
22. Lautrette A, Darmon M, Megarbane B, et al. A communication strategy and brochure for relatives of patients dying in the ICU. N Engl J Med. 2007;356:469-78.
23. Fujii T, Katayama S, Miyazaki K, et al. Translation and validation of the Japanese version of the measure of moral distress for healthcare professionals. Health Qual Life Outcomes. 2021;19:120.
24. 日本小児科学会. 重篤な疾患を持つ子どもの医療をめぐる話し合いのガイドライン（2024年改訂版）.

本資料はガイドラインの要約・解説です。原典の図表は転載していません。用量・手順は必ず原典で確認してください。ICUの終末期の意思決定と看取り全体（面談・家族支援・死の判定・チームのケア）は、レジデント向けの資料ICUの終末期と意思決定で扱っています。